再生障碍性贫血 ★☆☆（0~3 题）

- 骨髓造血衰竭
  - ①造血干祖细胞缺陷：骨髓 CD34 细胞↓“撒种子要三思”
  - ②造血微环境异常：骨髓脂肪化“干抽”
  - ③免疫异常：主要 CD8 T 细胞↑“不再爱过”
- 全血细胞↓（贫血、感染、出血），Ret ＜ 1%，多无肝脾肿大
  - 血小板↓最明显
  - 贫血在晚期出现
  - 可能可能最可能（2007、2008、2025、2026）
- 检查
  - 髂骨 / 胸骨等多部位骨髓穿刺或穿刺 + 活检（2007、2008、2025、2026）
    - 三系↓尤其巨核系（全片未见巨核细胞）、骨髓小粒空虚脂肪细胞和淋巴细胞↑（CD4/CD8 ↓）
    - 有时胸骨可见局灶增生活跃、但巨核细胞↓
  - 正细胞性贫血
  - NAP ↑
- 重型再障Ⅰ型（急性再障，2016）
  - 起病急、症状重、骨髓增生广泛重度低下
  - Ret 绝对值＜ 15、中性粒细胞＜ 0.5、血小板＜ 20
  - “15 岁就网恋、无中意的、回来被打了 20 大板后成了智障”
- 治疗
  - Plt ＜ 20：立即输血小板（2008、2026）
  - HSCT：＜ 40 岁 + 无感染 + 有合适供体的重型再障首选
  - 免疫抑制：抗淋巴 / 抗胸腺细胞球蛋白 ALG/ATG、糖皮质激素、免疫抑制剂
  - 雄激素